

CAPÍTULO 14.12

Lupus Eritematoso Sistémico

PERFIL EUNACOM 1.05.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **Lupus Eritematoso Sistémico (LES)** es la enfermedad prototipo de las patologías del tejido conectivo. Se caracteriza por ser una enfermedad autoinmune multisistémica, crónica y con una presentación clínica sumamente heterogénea ("la gran imitadora"). Su sello inmunológico es la presencia de anticuerpos antinucleares (**ANA**), aunque su diagnóstico requiere una correlación clínica precisa.

Manifestaciones Mucocutáneas

Son a menudo el signo inicial y se presentan en la gran mayoría de los pacientes. Su visibilidad permite una sospecha diagnóstica precoz.

- **Eritema Malar (Lupus cutáneo agudo):** Conocido como "mariposa lúpica". Es un eritema que afecta el dorso de la nariz y las mejillas.
- **Fotosensibilidad:** Aparición o exacerbación de las lesiones cutáneas tras la exposición a la luz solar (radiación UV).
- **Lupus Cutáneo Subagudo y Crónico:** Incluye variantes como el **lupus discoide** (lesiones circulares con bordes eritematosos y centro atrófico). Pueden existir de forma aislada o en el contexto de un LES sistémico.
- **Úlceras Orales:** Habitualmente son **indoloras** y aparecen en el paladar o mucosa oral.
- **Alopecia:** Puede ser difusa (pelo ralo) o cicatricial (definitiva, asociada a lupus discoide).
- **Fenómeno de Raynaud:** Isquemia digital episódica (dedos blancos, luego azules y rojos).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Diferenciación Clínica Clave: 1. El **Eritema Malar** del lupus típicamente **respeto el surco nasogeniano** y no afecta el mentón. 2. A diferencia de la **Dermatomiositis**, donde el eritema afecta los nudillos (pápulas de Gottron), en el **Lupus** el eritema de las manos afecta la **piel entre las articulaciones** (espacios interarticulares).

Compromiso Renal (Nefropatía Lúpica)

El riñón es uno de los órganos cuya afectación marca el pronóstico de la enfermedad.

- **Sedimento Urinario:** Se presenta como una **glomerulonefritis**, caracterizada por hematuria dismórfica (presencia de **acantocitos**) y cilindros eritrocitarios o hemáticos.
- **Proteinuria:** Puede variar desde rangos leves hasta un **Síndrome Nefrótico** franco (especialmente en la nefropatía membranosa lúpica).
- **Deterioro de la Función Renal:** Puede presentarse como una **Insuficiencia Renal Aguda** (en casos de glomerulonefritis rápidamente progresiva) o evolucionar a una enfermedad renal crónica por daño acumulado.

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología de la nefritis lúpica se basa en el **depósito de complejos inmunes** en el glomérulo, lo que activa la cascada del complemento y genera inflamación tisular severa.

Alteraciones Hematológicas

El hemograma es una herramienta fundamental en la sospecha de LES. Generalmente, el lupus tiende a producir una **citopenia de las tres líneas**:

TABLA 14.12.1: LÍNEA CELULAR VS ALTERACIÓN

LÍNEA CELULAR	ALTERACIÓN	HALLAZGO EUNACOM
Glóbulos Blancos	Leucopenia	< 4.000/mm ³ (frecuentemente expensas de linfocitos).
Linfocitos	Linfopenia	< 1.000 - 1.500/mm ³ .
Glóbulos Rojos	Anemia Hemolítica	De tipo autoinmune (Coombs directo positivo).
Plaquetas	Trombocitopenia	< 100.000/mm ³ , a veces como un PTI secundario.

Otras Manifestaciones Sistémicas

- **Osteoarticular:** Mialgias, artralgias y **artritis lúpica**. A diferencia de la **Artritis Reumatoide**, la artritis del lupus es habitualmente **no erosiva**.
- **Serositis:** Inflamación de las serosas que se traduce en derrame pleural, pericarditis lúpica o, menos frecuentemente, peritonitis lúpica.
- **Neurológicas:** Psicosis lúpica, convulsiones, meningitis aséptica o accidentes vasculares encefálicos (AVE).
- **Sistémicas generales:** Fiebre, baja de peso y compromiso del estado general.

Marcadores Inmunológicos y Diagnóstico

El diagnóstico se basa en la suma de criterios clínicos e inmunológicos. La regla clásica dicta que la presencia de **4 o más criterios** (en cualquier momento de la evolución) confirma el diagnóstico.

Autoanticuerpos

1. **ANA (Anticuerpos Antinucleares):** Muy **sensibles** (positivos en el 90-95% de los casos). Un ANA negativo aleja mucho el diagnóstico, pero un ANA positivo no lo confirma por sí solo (baja especificidad). 2. **Anti-DNA de doble hebra (anti-dsDNA):** Muy **específico**. Sus títulos se correlacionan con la **actividad de la enfermedad** y el riesgo de nefritis. 3. **Anti-Sm (Anti-Smith):** El más específico para LES, aunque menos sensible que el anti-DNA. 4. **Complemento (C3 y C4):** Se encuentran **disminuidos** (hipocomplementemia) durante los brotes de actividad debido al consumo por depósito de complejos inmunes. 5. **Anticuerpos Antifosfolípidos:** Pueden estar presentes y condicionar un **Síndrome Antifosfolípido** secundario (trombosis, abortos a repetición).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

El **Anti-dsDNA** es el marcador de elección para monitorizar la **actividad lúpica**. Si los títulos suben, es probable que el paciente esté entrando en un "brote".

Pronóstico y Gravedad

- Los factores que determinan un peor pronóstico incluyen:
- Presencia y severidad del **daño renal**.
- Afectación del **Sistema Nervioso Central**.
- Títulos persistentemente elevados de **Anti-dsDNA**.
- Grado de actividad clínica mantenida.

Tratamiento

El manejo depende de la gravedad y de los órganos afectados.

1. Manejo del Lupus Estable (Leve-Moderado)

- **Hidroxicloroquina:** Es el fármaco de elección para **todos** los pacientes con lupus. Mejora la supervivencia, reduce brotes y protege contra el daño orgánico. - **Corticoides:** Se utiliza **Prednisona** en dosis bajas para controlar síntomas. - **Ahorrradores de Corticoides:** Fármacos inmunomoduladores como **Azatioprina** o **Leflunomida**, que permiten reducir la dosis de prednisona y sus efectos adversos.

2. Manejo de Cuadros Graves (Brote Lúpico)

Se utiliza en casos de nefritis lúpica grave, anemia hemolítica severa, compromiso del SNC o vasculitis. - **Pulsos de Metilprednisolona:** Corticoides endovenosos a dosis altas. - **Inmunosupresores Potentes:** - **Ciclofosfamida:** El esquema clásico para cuadros agudos graves. - **Micofenolato mofetilo:** Muy utilizado en nefritis lúpica. - **Rituximab:** Anticuerpo anti-CD20 (contra linfocitos B), reservado para casos refractarios.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El uso de inmunosupresores y corticoides aumenta significativamente el **riesgo de infecciones oportunistas**. Siempre se debe monitorizar la aparición de fiebre o síntomas infecciosos en estos pacientes.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente con LES presenta proteinuria, hematuria dismórfica y complemento C3 y C4 bajos. ¿Cuál es la fisiopatología de la afectación renal?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Lupus Eritematoso Sistémico. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Eritema malar (mariposa lúpica) respeta surco nasogeniano; úlceras orales son indoloras
- Afectación renal con glomerulonefritis hipocomplementémica (baja C3/C4), proteinuria y posible síndrome nefrótico
- Alteraciones hematológicas: leucopenia con linfopenia, anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia/PTI
- ANA sensible (90%); anti-DNA doble hebra y anti-Smith son específicos
- Anti-DNA doble hebra es marcador de actividad lúpica y pronóstico
- Tratamiento estable: hidroxicloroquina + prednisona + ahorradores de corticoides
- Cuadros graves: pulsos de corticoides EV + inmunosupresores (ciclofosfamida, rituximab)
- En lupus el eritema de dedos afecta la piel entre articulaciones (vs dermatomiositis que afecta nudillos)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO)

PREGUNTA 1

Paciente con LES presenta proteinuria, hematuria dismórfica y complemento C3 y C4 bajos. ¿Cuál es la fisiopatología de la afectación renal?

- ☐ A) Vasculitis de vaso pequeño ANCA positiva
- ☐ B) Depósito de complejos inmunes con consumo de complemento
- ☐ C) Trombosis de arteria renal por SAF
- ☐ D) Nefritis intersticial por hidroxicloroquina
- ☐ E) Amiloidosis renal secundaria

PREGUNTA 2

¿Cuál de los siguientes marcadores es tanto marcador de actividad como de pronóstico en el LES?

- ☐ A) ANA
- ☐ B) Anti-Smith
- ☐ C) Anti-DNA doble hebra
- ☐ D) Factor reumatoide
- ☐ E) Anti-Ro

PREGUNTA 3

¿Cuál es el fármaco que debe recibir todo paciente con lupus estable actualmente?

- ☐ A) Metotrexato
- ☐ B) Ciclofosfamida
- ☐ C) Hidroxicloroquina
- ☐ D) Rituximab
- ☐ E) Azatioprina

RESUMEN: LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad del tejido conectivo ANA positiva potencialmente grave. Las manifestaciones mucocutáneas incluyen eritema malar (mariposa lúpica que respeta surco nasogeniano), fotosensibilidad, lupus cutáneo subagudo/crónico, úlceras orales indoloras, alopecia, fenómeno de Raynaud y eritema interarticular de los dedos (a diferencia de la dermatomiositis que afecta los nudillos). La afectación renal es frecuente con glomerulonefritis (hematuria dismórfica, proteinuria, síndrome nefrótico), pudiendo evolucionar a insuficiencia renal aguda o crónica. Las alteraciones hematológicas incluyen leucopenia con linfopenia, anemia hemolítica autoinmune y trombocitopenia/PTI. También presenta serositis, afectación neurológica y articular. Marcadores: ANA (sensible, 90%), anti-DNA doble hebra y anti-Smith (específicos), complemento bajo (C3/C4), y anticuerpos antifosfolípidos. El tratamiento del lupus estable es hidroxicloroquina + prednisona + ahorradores de corticoides. Los cuadros graves requieren pulsos de corticoides EV + inmunosupresores (ciclofosfamida, micofenolato, rituximab).